令和8年6月施行

令和8年度 診療報酬改定

【糖尿病・内分泌編】

生活習慣病管理料・眼科歯科連携加算・透析・薬価

厚生労働省公式資料・糖尿病標準診療マニュアル2026年版に基づく

医知創造ラボ　今村久司

脳神経内科専門医

糖尿病・内分泌領域の主要改定ポイント

1. **生活習慣病管理料（Ⅰ）（Ⅱ）の見直し**
   包括範囲縮小、血液検査要件化、署名不要
2. **眼科医療機関連携強化加算【新設】**
   60点/年1回 — 糖尿病網膜症の早期発見
3. **歯科医療機関連携強化加算【新設】**
   60点/年1回 — 歯周病との双方向的関連
4. **充実管理加算の3段階再編**
   30点/20点/10点 — 実績に基づく評価
5. **在宅自己注射の適用拡大**
   糖尿病以外の併存疾患にも算定可能
6. **透析：人工腎臓▲20点＋充実加算+20点**
   腎代替療法診療体制充実加算の新設

生活習慣病管理料（Ⅰ）（Ⅱ）の見直し

包括範囲の縮小

併算定可能な医学管理料

~~16項目~~ → **37項目**

血液検査の要件化

管理料（Ⅰ）の算定要件として追加

6か月に1回以上

療養計画書の簡素化

患者署名が不要に → 事務負担軽減

糖尿病＋他疾患を併存する患者の管理料算定の自由度が大幅に向上。併算定可能項目を確認し、漏れなく算定することが重要。

眼科医療機関連携強化加算【新設】

60点
年1回

対象：糖尿病を主病とする患者

要件：眼科受診の必要性を認め連携を実施

目的：糖尿病網膜症の早期発見・治療

管理料（I）・（II）の双方で算定可

臨床的意義

糖尿病網膜症は無症状のまま進行。増殖網膜症では失明リスクあり。内科通院中でも眼科未受診の患者は少なくない。

内科主治医 → 眼科受診の必要性を判断 → 患者同意を取得 連携を実施 → 眼科を受診 60点算定

歯科医療機関連携強化加算【新設】

60点
年1回

対象：糖尿病を主病とする患者

要件：歯科受診の必要性を認め連携を実施

目的：歯周病の予防・診断・治療

管理料（I）・（II）の双方で算定可

エビデンスの背景

歯周病は「第6の合併症」。歯周病治療によりHbA1cが改善するエビデンスあり。日本糖尿病学会も歯科連携を推奨。

糖尿病

悪化 →
← 改善

歯周病

充実管理加算（旧：外来データ提出加算）の再編

加算1 30点	体制整備＋十分な実績（上位20%）
加算2 20点	体制整備＋相当の実績（中位30%）
加算3 10点	体制整備のみ（下位50%）

評価基準：検査実施患者割合 / 眼科・歯科連携加算の算定割合 / 受診間隔の適切性

経過措置：R8年3月31日時点で継続データ提出 → R9年3月31日まで加算1相当で評価

在宅自己注射指導管理料の適用拡大

改定前

糖尿病に適応のある薬剤
に限定して算定

例）インスリン、GLP-1受容体作動薬

→

改定後

糖尿病以外の併存疾患
への自己注射も算定可能

例）骨粗鬆症（テリパラチド）
関節リウマチ（MTX皮下注）

実務上のポイント

- 糖尿病患者は高齢化に伴い複数の併存疾患を抱えることが多い
- インスリン＋骨粗鬆症薬などの一体管理が可能に
- 該当患者の洗い出しを行い、算定漏れを防ぐ

透析関連の改定 — 人工腎臓と腎代替療法

人工腎臓（J038）基本点数

全区分で **▲20点**

腎代替療法診療体制充実加算【新設】

+20点

取得で従来点数を維持可能

施設基準（主な要件）

1. 災害対策：ハザードマップに基づくリスク評価・マニュアル策定・年1回以上の訓練
2. 患者説明：腎代替療法の選択肢（HD・PD・腎移植）について繰り返し説明
3. 実績要件（いずれか）：腹膜灌流指導管理24回以上/年 or 腎移植2名以上/年

薬価改定とガイドライン更新

薬価改定（R8年4月施行）

全体：▲0.86%

リベルサス錠（セマグルチド）

改定時加算 +5%

「真の臨床的有用性の検証に係る加算」

標準診療マニュアル2026年版

GLP-1 RA（経口）推奨強化

心血管既往・肥満 →
積極的に投与開始してよい

DPP-4阻害薬との併用禁忌

GLP-1 RA・GIP/GLP-1 RAとの併用は避ける

注意

DPP-4阻害薬 → GLP-1 RA / GIP/GLP-1 RA 切替時は
DPP-4阻害薬の中止を確実に行うこと
作用機序の重複 → 低血糖リスク増大、上乗せ効果なし
チルゼパチド（マンジャロ）等のGIP/GLP-1 RAも同様

Take Home Message

1. 眼科・歯科連携加算（各60点/年1回）— 合併症予防と算定の両立
2. 生活習慣病管理料：併算定可能項目 16→37に拡大
3. 充実管理加算 3段階評価 — 加算1（30点）は実績が必要
4. 在宅自己注射：併存疾患（骨粗鬆症・RA等）にも算定拡大
5. 透析：基本▲20点 → 腎代替療法充実加算+20点で相殺可
6. GLP-1 RA：心血管既往・肥満で積極投与。DPP-4併用禁忌

ご視聴ありがとうございました